Autor: Francisco Javier López Sánchez. Médico Gerencia Urgencias y Emergencias (UME 17)

1. DEFINICIÓN

El dolor torácico agudo se define como toda sensación álgica localizada en la zona comprendida entre el diafragma y la base del cuello, de instauración reciente.

Las causas de dolor torácico son múltiples (ver anexo 1), desde emocionales (ansiedad) a una disección aortica. Por lo que el problema más importante a la hora de evaluar un dolor torácico estriba en diferenciar patología potencialmente mortal, de molestias torácicas que no comprometen la vida del enfermo.

La valoración del dolor torácico se basa fundamentalmente en la clínica, exploración física y exploraciones complementarias básicas. Tras esta valoración podremos clasificar el dolor en uno de los siguientes grupos (ver anexo 2):

1.1. Patología potencialmente grave
1.2. Patología urgente no vital
1.3. Patología banal

2. ATENCIÓN INICIAL TELEFÓNICA

2.1. PALABRAS CLAVE: taquicardia, palpitaciones, dolor torácico, dificultad respiratoria, síncope, opresión en el pecho, pinchazo, sensación de falta de aire.

2.2. RECOMENDACIONES DESDE CCU: mantener la calma, observación del paciente, si pérdida de consciencia comprobar respiración y pulso. Si se produce parada iniciar RCP (ver protocolo RCP telefónica). Recomendaciones específicas según la sospecha etiológica.

3. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO AL LUGAR DEL AVISO

Se adoptaran las medidas habituales de autoprotección, seguridad en el escenario y seguridad para el paciente.

CELDRAN GIL, FRANCISCO 15/12/2020 09:54:02
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-2910d5c2b-3eb3-0a83-da1e-0050569b6280

CELDRAN GIL, FRANCISCO 15/12/2020 09:54:02
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-2910d5c2b-3eb3-0a83-da1e-0050569b6280

4. EVALUACION INICIAL:

4.1. EVALUACIÓN RÁPIDA:

Fundamental, en el mismo momento de la llegada, para descartar inicialmente patologías que puedan poner en riesgo la vida del paciente.

- Comprobar el estado general del paciente y realizar una breve anamnesis.
- Evaluar los signos vitales y descartar datos de alarma.
- Si sospecha de patología cardiaca realización ECG en los primeros 5 minutos.

Signos de gravedad

1.- bajo nivel de conciencia (GCS <12) o focalidad neurológica
2.- inestabilidad hemodinámica (PA sistólica <90mmHg o FC >100lpm)
3.- HTA extrema (PA sistólica >180mmHg / PA diastólica > 110-120mmHg)
4.- taquipnea (FR >30rpm) o bradipnea (FR <10rpm)
5.- insuficiencia respiratoria (SpO2 < 90%) u obstrucción vía aérea

Datos clínicos de alarma

1. Cianosis o signos de mala perfusión tisular
2. Debilidad de pulsos periféricos
3. Síntomas vegetativos
4. Signos de bajo gasto cardiaco
5. Pulso arrítmico
6. Disnea, tiraje, alteración movimientos respiratorios
7. Auscultación pulmonar patológica

4.2. RECOGIDA DE DATOS DE FILIACIÓN COMPLETOS

4.3. ANAMNESIS

4.3.1. ALERGIAS
4.3.2. ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES así como factores de riesgo cardiovascular.
4.3.3. SITUACIÓN BASAL / CALIDAD DE VIDA
4.3.4. TRATAMIENTO ACTUAL
4.3.5. ANAMNESIS DEL EPISODIO ACTUAL: debe dirigirse para encuadrar el dolor en uno de los perfiles clásicos de dolor torácico (ver anexo 3), importante conocer cuándo empezó, tipo de comienzo (brusco o progresivo), si ha sido autolimitado, si es continuo o intermitente, si ha cesado o continúa con dolor, qué estaba haciendo cuando empezó y si ha tenido antes ese dolor, además debemos precisar las siguientes características del dolor:

CELDRAN GIL, FRANCISCO 15/12/2020 09:54:02
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-2910d5c2b-3eb3-0a83-da1e-0050569b6280

- LOCALIZACIÓN E IRRADIACIÓN: retroesternal, precordial, costal, cuello, mandíbula, espalda, miembros superiores y abdomen.
- INTENSIDAD: leve, moderado o intenso.
- DURACIÓN: fugaz, minutos, horas o días.
- CALIDAD: opresivo, punzante, urente o lacerante.
- CIRCUNSTANCIAS QUE LO DESENCADENAN O AGRAVAN: esfuerzo, frio, respiración, tos, deglución, ingestión, presión, cambios posturales.
- FACTORES QUE LO ALIVIAN: reposo, inmovilización, cambios posturales, ingestión analgésicos, antiácidos, nitratos o relajantes musculares.
- SINTOMAS ACOMPAÑANTES: cortejo vegetativo (nauseas, vómitos, sudoración, piloerección, sequedad de boca), disnea, palpitaciones, inestabilidad, sincope, fiebre o parestesias.

4.4. EXPLORACION FíSICA Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

4.4.1. EXPLORACIÓN FÍSICA

4.4.1.1. NIVEL DE CONCIENCIA Y ASPECTO GENERAL

4.4.1.2. CONSTANTES VITALES: frecuencia cardiaca y respiratoria, presión arterial, saturación periférica de oxígeno, temperatura corporal y diuresis.

4.4.1.3. INSPECCIÓN Y PALPACIÓN DEL TÓRAX: búsqueda de asimetrías en los movimientos torácicos y de desplazamiento de la tráquea (neumotórax), contusiones, fracturas costales, lesiones dérmicas (herpes zoster), masas palpables dolorosas (tromboflebitis superficial de las venas intercostales o síndrome de Mondor). Nota: la reproducción del dolor mediante la palpación del área donde se refiere el dolor es sugestivo de origen mecánico.

4.4.1.4. AUSCULTACIÓN CARDIACA: detectar soplos (valvulopatías), extratonos (IAM), ritmo de galope (insuficiencia cardiaca), roce pericárdico (pericarditis aguda) o trastornos del ritmo.

4.4.1.5. EXPLORACIÓN VASCULAR Y DE LAS EXTREMIDADES: palpar pulsos centrales y periféricos (aneurisma disecante), diferencias tensionales en las extremidades (coartación aorta), pulso saltón (insuficiencia aórtica), ingurgitación yugular (elevación presión venosa central), pulso paradójico (taponamiento cardiaco), presencia trombosis venosa periférica y edemas.

4.4.1.6. EXPLORACIÓN RESPIRATORIA: aleteo nasal, taquipnea, utilización de la musculatura accesoria y cianosis. Auscultación pulmonar:

- Crepitantes unilaterales (neumonía, infarto pulmonar)
- Crepitantes bilaterales (insuficiencia cardiaca)

- Disminución o abolición murmullo vesicular (derrame pleural, neumotórax)
- Soplo bronquial: neumonía
- Roce pleural: pleuritis

4.4.1.7. EXPLORACIÓN ABDOMINAL: de forma sistemática, buscando posible origen infradiafragmático del dolor torácico.

4.4.1.8. OBSERVACIÓN Y PALPACIÓN PIEL: descartar enfisema subcutáneo.

4.4.2. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (ver anexo 4)

4.4.2.1. ECG DE SUPERFICIE DE 12 DERIVACIONES: su realización es obligada ante todo dolor torácico (salvo que el cuadro clínico y exploración física descarte de manera clara y evidente patología cardiovascular). Su rentabilidad es más alta durante la fase de dolor, y debe repetirse posterior a ella para comparar los cambios hallados en caso de duda diagnóstica. Para su valoración, sobre todo cuando hay alteraciones permanentes en el ECG, es muy útil la comparación con ECG previos del paciente.

4.4.2.2. DERIVACIONES POSTERIORES (V7, V8 y V9): deben realizarse ante la sospecha de infarto posterior (descenso del segmento ST >0´5mm en V1 a V3)

4.4.2.3. DERIVACIONES DERECHAS (V3R, V4R, V5R y V6R): deben realizarse en pacientes con infarto inferior (elevación segmento ST en cara inferior -II, III y aVF-) por sospecha de infarto del ventrículo derecho.

5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Con la anamnesis y exploración física podremos encuadrar el dolor dentro de uno de los distintos perfiles de dolor torácico (ver anexo 3), asimismo pueden ser útiles para el diagnóstico diferencial las pruebas diagnóstico-terapéuticas de interés práctico.
Si los resultados son positivos, pueden servir de orientación hacia la causa del dolor torácico, aunque no tienen valor diagnóstico. Por ello, siempre deben valorarse con cautela.

5.1. NITRATOS: alivia dolor anginoso en 1-2 minutos, pero también puede mejorar el dolor del espasmo esofágico.
5.2. ANTIÁCIDOS, ANTIH2 O INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES: suelen calmar en pocos minutos la esofagitis y la epigastralgia de origen péptico.
5.3. SALICILATOS Y OTROS ANTIINFLAMATORIOS: mejoran el dolor de tipo osteomuscular, pleural y pericárdico.

CELDRAN GIL, FRANCISCO 15/12/2020 09:54:02
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-29145c2b-3eb3-0a83-da1e-0050569b6280

5.4. ANSIOLÍTICOS: mejoran el dolor de tipo psicógeno

6. DIAGNÓSTICO

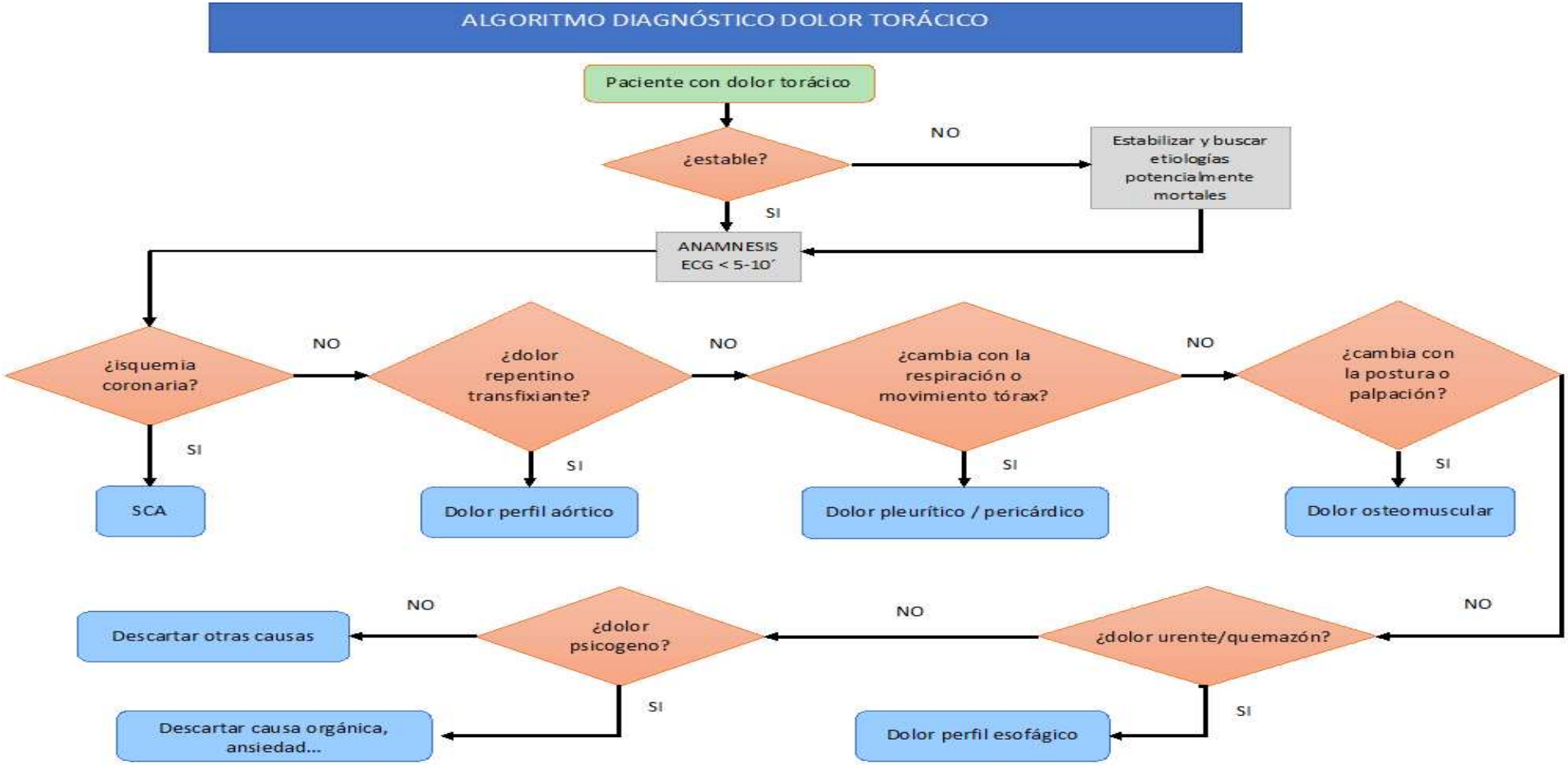
DIAGNÓSTICOS	CIE-9 MC	DIAGNÓSTICOS	CIE-9 MC
Abdomen agudo	**567.9**	Herpes zoster	**053.9**
Aneurisma aorta	**441**	Insuficiencia cardiaca	**428**
ANGOR	**413**	Insuficiencia respiratoria aguda	**518.82**
ANSIEDAD	**300**	Intoxicación otras sustancias no medicamentosas	**989**
Arritmia cardiaca NSP	**427.9**	Neumonía	**486**
Bronquitis aguda	**466.0**	Neumotórax	**512**
Cervicalgia	**723.1**	Neumo/hemotórax traumático	**860**
Cólico biliar	**575.9**	Neuralgia	**729.2**
Contractura muscular/mialgia	**729.1**	Palpitaciones	**785.1**
Contusión tronco	**922**	Parada cardiorrespiratoria	**427.5**
Crisis hipertensiva	**401.9**		
Disnea y anomalías resp	**786.09**	Pericarditis aguda	**420.9**
Dispepsia	**536.8**	Simulador	**V65.2**
Dolor abdominal	**789.0**	Sincope/lipotimia/perdida conocimiento	**780.2**
Dolor articular	**719.4**	**SCACEST**	**410**
Dolor crónico	**338.2**	**SCASEST**	**410.7**
Dolor espalda	**724.9**	Traqueítis	**464.1**
DOLOR TORÁCICO	**786.5**	TEP	**415.1**
DOLOR TORÁCICO ATÍPICO /MECÁNICO	**786.59**		
Dolor torácico pleurítico	**786.52**		
Emergencia hipertensiva	**437.2**		
Enfisema subcutáneo	**958.7**		
Fractura hueso abierta	**829.1**		
Fractura hueso cerrada	**829.0**		
Gastritis/duodenitis	**535**		

CELDRAN GIL, FRANCISCO 15/12/2020 09:54:02
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-291d5c2b-3eb3-0a83-da1e-0050569b6280

Servicio Murciano de Salud

DOLOR TORÁCICO

061 GERENCIA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS



CELDRAN GIL, FRANCISCO 15/12/2020 09:54:02
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-291d5c2b-3eb3-0e83-da1e-0050569b6280

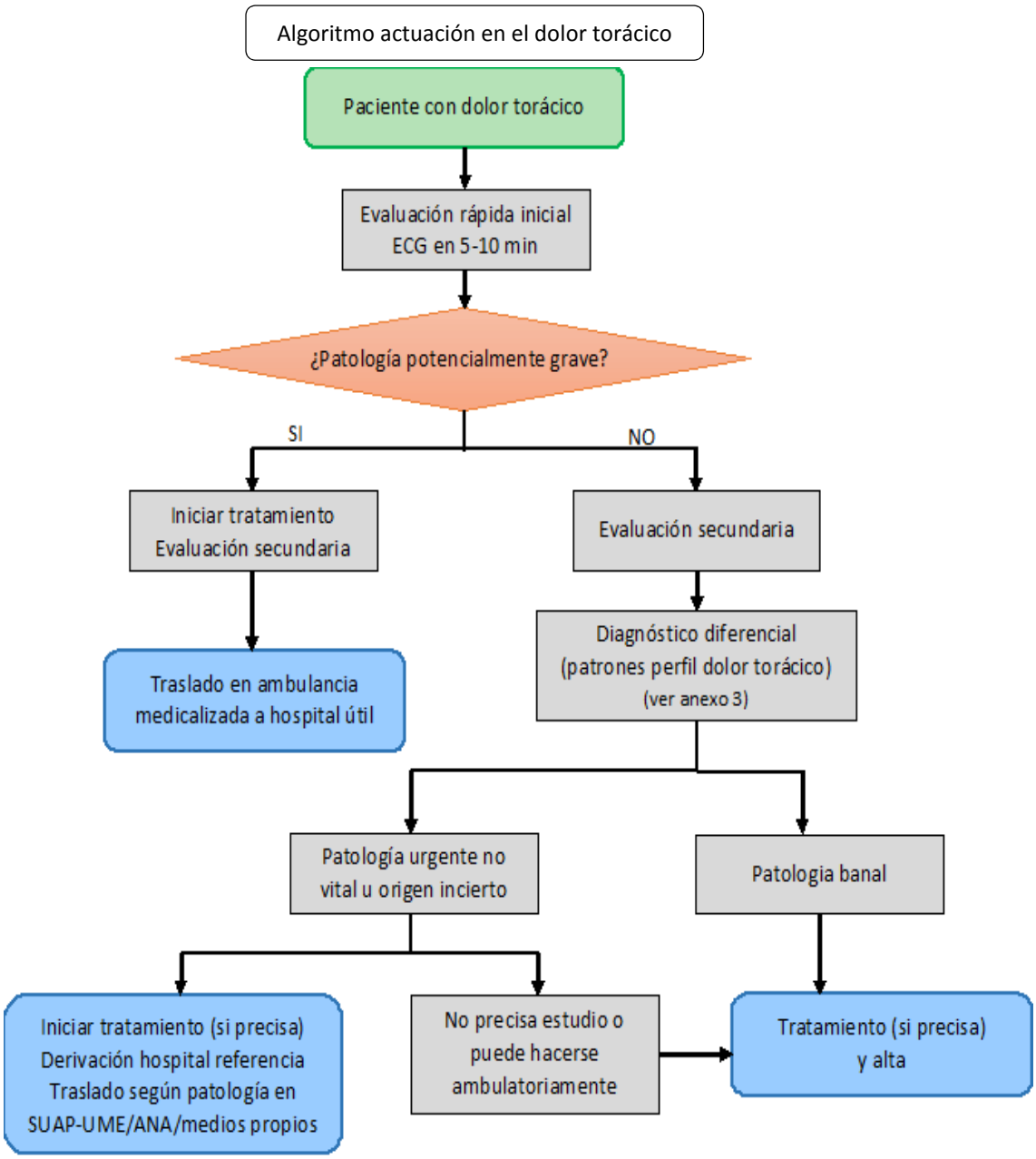
CELDRAN GIL, FRANCISCO 15/12/2020 09:54:02
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-291d5c2b-3eb3-0a83-da1e-0050569b6280

7. TRATAMIENTO

7.1.1. Estabilización hemodinámica

7.1.2. Tratamiento etiológico

7.1.3. Tratamiento sintomático



CELDRAN GIL, FRANCISCO 15/12/2020 09:54:02
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-2910d5c2b-3eb3-0a83-da1e-0050569b6280

8. DESTINO

8.1. Patología potencialmente grave: traslado en ambulancia medicalizada (SUAP o UME) a **hospital útil** dependiendo del tipo de patología.

8.2. Patología urgente no vital: en función de los criterios de cada tipo de enfermedad:

- 8.2.1. Traslado en ambulancia medicalizada (SUAP o UME) a hospital de referencia.
- 8.2.2. Traslado en ambulancia no asistencial a hospital de referencia.
- 8.2.3. Alta para estudio y tratamiento ambulatorio.

8.3. Patología banal: alta y seguimiento ambulatorio.

9. INDICADORES

GRUPO[1] 1. INDICADORES DE ACTIVIDAD	
1.01	Número de asistencias de las unidades móviles.
1.02	Tiempo de activación de las unidades asistenciales.
1.03	Tiempo de llegada al aviso.
GRUPO 2. SEGURIDAD.	
2.01	Adecuación de la actuación al procedimiento.
2.02	Tasa de mortalidad “in situ”.
GRUPO 3. CALIDAD CIENTÍFICO TÉCNICA	
3.01	Cumplimentación correcta de la Historia Clínica.
3.02	Tasa de auscultación cardio - pulmonar
3.03	Tasa de pacientes con realización ECG 12 derivaciones
3.04	Identificación factores de riesgo cardiovascular
3.05	Administración si cardiopatía isquémica de dosis de carga de antiagregantes (si indicado)
3.06	Realización derivaciones derechas si elevación ST en cara inferior
3.07	Realización derivaciones posteriores si descenso ST en V1 a V3
GRUPO 4. SATISFACCIÓN.	
4.01	Nivel de calidad percibida por el usuario (encuesta de satisfacción)
4.02	Tasa de reclamaciones.

CELDRAN GIL, FRANCISCO 15/12/2020 09:54:02
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-2910d5c2b-3eb3-0a83-da1e-0050569b6280

10. ANEXOS

ANEXO 1. CAUSAS DE DOLOR TORÁCICO AGUDO.

1. Cardiológicas
   - 1.1. Cardiopatía isquémica
   - 1.2. Pericarditis/miocarditis
   - 1.3. Valvulopatias
   - 1.4. Miocardiopatía hipertrófica obstructiva

2. Pleuropulmonares
   - 2.1. Neumotórax
   - 2.2. Neumomediastino
   - 2.3. Pleurodinia y pleuritis
   - 2.4. Neumonía / derrame
   - 2.5. Traqueo bronquitis
   - 2.6. Procesos mediastínicos
   - 2.7. neoplasias

3. Vasculares
   - 3.1. Tromboembolia pulmonar (TEP)
   - 3.2. Síndrome aórtico agudo
   - 3.3. Hipertensión pulmonar o sistémica grave

4. Digestivas
   - 4.1. Enfermedad esofágica (espasmo, reflujo, esofagitis, hernia hiatal)
   - 4.2. Perforación de víscera hueca (esófago, estómago, duodeno)
   - 4.3. Ulcera péptica
   - 4.4. Pancreatitis
   - 4.5. Enfermedad biliar
   - 4.6. Síndrome de ángulo esplénico

5. Osteomusculares
   - 5.1. Costocondritis o síndrome de Tietze
   - 5.2. Discopatía cervical o torácica
   - 5.3. Trastornos articulares (cervicoartrosis, bursitis, periartritis)
   - 5.4. Síndrome del plexo braquial
   - 5.5. Espasmo muscular y fibrositis
   - 5.6. Dolor inespecífico de la pared torácica
   - 5.7. Traumatismo torácico
   - 5.8. Volet costal

6. Psicógenas y otras
   6.1. Estados de ansiedad (síndrome de hiperventilación)
   6.2. Depresión
   6.3. Simulación
   6.4. Ingesta de cocaína
   6.5. Herpes zoster

ANEXO 2. VALORACIÓN EN URGENCIAS DEL DOLOR TORÁCICO AGUDO.

1. PROCESOS POTENCIALMENTE GRAVES:

   1.1. Síndrome coronario agudo (SCA)
   1.2. Síndrome aórtico agudo
   1.3. Taponamiento cardiaco
   1.4. Tromboembolismo pulmonar (TEP)
   1.5. Neumotórax a tensión
   1.6. Perforación esofágica
   1.7. Volet costal

2. PROCESOS URGENTES NO VITALES

   2.1. Pericarditis
   2.2. Prolapso de la válvula mitral
   2.3. Neumonía
   2.4. Derrame pleural
   2.5. Brote ulceroso
   2.6. Espasmo esofágico
   2.7. Fractura costal

3. PROCESOS BANALES

   3.1. Costocondritis
   3.2. Pleurodinia
   3.3. Herpes zoster
   3.4. Estados de ansiedad
   3.5. Dolor origen muscular
   3.6. Otros

ANEXO 3. PERFILES CLÁSICOS DE DOLOR TORÁCICO.

CELDRAN GIL, FRANCISCO 15/12/2020 09:54:02
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-2910d5c2b-3eb3-0a83-da1e-0050569b6280

PERFIL ISQUÉMICO

Localización e irradiación:

Retroesternal como "mano en garra" o "puño cerrado".

Puede irradiarse a pectorales, mandíbula, codos, muñecas, epigastrio o región interescapular

Intensidad:

Inicio súbito e intensidad variable. Muy intenso en el IAM

Duración:

- Angina típica <10 min
- angina prolongada >20min
- IAM >40 min

Calidad:

Opresivo, transfixiante, constrictivo con sensación de muerte inminente. Rara vez como quemazón o dolor punzante y nunca como pulsátil ni como pinchazos

Factores agravantes:

Estrés físico o mental, frio, ingestión, sueño (angina vasoespástica o de Prinzmetal), y en general cualquier circunstancia que aumente el consumo miocárdico de oxígeno.

Factores que alivian:

Reposo, nitratos sublinguales o intravenosos

Síntomas acompañantes:

Cortejo vegetativo: nauseas, vómitos, palidez, sudoración, piloerección, ansiedad, debilidad y palpitaciones

Exploración física:

En la mayoría de casos exploración normal
Soplo de insuficiencia mitral, ritmo de galope y roce pericárdico en el IAM

Factores de riesgo/antecedentes de interés:

HTA, Diabetes, hipercolesterolemia, tabaquismo, obesidad, sedestación, edad avanzada, insuficiencia renal crónica, consumo cocaína reciente.
Historia personal de cardiopatía isquémica previa o enfermedad aterosclerótica a otro nivel
Historia familiar cardiopatía isquémica precoz (<55 años varones, <65 años en mujeres)

ECG:

Un ECG normal no descarta proceso grave
Ante sospecha cardiopatía isquémica realizar ECG seriados para valorar cambios evolutivos sugerentes de isquemia y siempre que refiera dolor.

***EN MUJERES, ANCIANOS Y DIABÉTICOS ES FRECUENTE PRESENTACIÓN ATIPICA**

CELDRAN GIL, FRANCISCO 15/12/2020 09:54:02
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-29 1d5c2b-3eb3-0a83-da1e-0050569b6280

PERFIL PERICÁRDICO

Localización e irradiación:

Retroesternal o precordial. Puede ser referido en el ápex, hemitórax derecho o parte superior abdomen. Puede irradiarse a hombro izquierdo y cuello

Intensidad:

Inicio subagudo variable. Rara vez tan intenso como en el IAM

Duración:

Variable, en general de días

Calidad:

Como dolor de carácter pleurítico (punzante), coronario (opresivo) o dolor sincrónico con los latidos cardiacos que es patognomónico pero infrecuente

Factores agravantes:

Decúbito supino, respiración profunda, deglución, tos, rotación tórax

Factores que alivian:

Flexión tronco, decúbito prono, respiración superficial

Síntomas acompañantes:

Dependen causa: infección vías respiratorias (vírica), síndrome constitucional (neoplasia)

Exploración física:

Roce pericárdico, signos de taponamiento cardiaco: pulso paradójico (disminución tensión arterial sistólica en +10mmHg durante la inspiración)

Factores de riesgo/antecedentes de interés:

Infección respiratoria o gastrointestinal, IAM o cirugía cardiaca reciente
Enfermedades autoinmunes
Uso de determinados fármacos (procainamida, hidralazina, isoniazida)

ECG:

Existen cambios evolutivos a lo largo del tiempo
Lo más precoz y específico es el descenso del segmento PR
Lo más frecuente es la elevación difusa del segmento ST cóncava hacia arriba

Causas:

Pericarditis o miopericarditis de cualquier causa

CELDRAN GIL, FRANCISCO 15/12/2020 09:54:02
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-2910d5c2b-3eb3-0a83-da1e-0050569b6280

C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ªPlanta
30005 Murcia

Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 | Transporte Sanitario UNE 179002

(Documento firmado electrónicamente al margen)

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de Murcia. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en http://10.181.8.6/intranet/

PERFIL PLEURÍTICO

Localización e irradiación:

Región torácica lateral (dolor en punta de costado) puede irradiarse al resto del tórax y cuello

- Si afectación pleura mediastínica irradiación a zona retroesternal y cuello
- Si afectación pleura diafragmática localización más toracoabdominal con irradiación a ambos hombros

Intensidad:

Inicio agudo e intenso

Duración:

Variable, en general días

Calidad:

Punzante como una cuchillada

Factores agravantes:

Movimientos respiratorios profundos, tos, estornudos

Factores que alivian:

Respiración superficial, inmovilización zona afectada

Síntomas acompañantes:

Tos, disnea. Fiebre, hemoptisis (neumonía, neoplasia)

Exploración física:

Frecuencia respiratoria, saturación de O_2, presión arterial.
Roce pleural y semiología derrame pleural (matidez, disminución o abolición murmullo vesicular y de las vibraciones vocales) o de neumotórax (sonido hiperclaro a la percusión torácica, disminución o abolición murmullo vesicular y de las vibraciones vocales)

Factores de riesgo/antecedentes de interés:

Neumotórax: pacientes jóvenes, delgado, fumador, traumatismo torácico reciente
TEP: inmovilización, cirugía reciente, mujeres en tratamiento con anticonceptivos orales

ECG:

No alteraciones especificas
En ocasiones taquicardia sinusal
En TEP lo más frecuente taquicardia sinusal. Puede presentar BCRD o alteraciones inespecíficas de la repolarización. Patrón S1Q3T3 es infrecuente.

Causas:

Cualquier patología que irrite la pleura. Las causas más importantes son:

- Neumotórax.
- tromboembolismo pulmonar.
- neumonía o derrame pleural.

CELDRAN GIL, FRANCISCO 15/12/2020 09:54:02
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-2910d5c2b-3eb3-0a83-da1e-0050569b6280

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de Murcia. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en http://10.181.8.6/intranet/

PERFIL AÓRTICO

Localización e irradiación:

En parte anterior tórax, espalda, zona interescapular o abdomen. Característica la migración hacia cuello, espalda y flancos, puede irradiarse a abdomen y extremidades inferiores a medida que avanza la disección

Intensidad:

Inicio muy brusco e intenso

Duración:

Variable, de minutos a horas

Calidad:

Desgarrante o lacerante

Factores agravantes:

Hipertensión, embarazo, síndrome de Marfan

Factores que alivian:

Control presión arterial y morfina

Síntomas acompañantes:

Cortejo vegetativo, sincope, déficit neurológico, signos insuficiencia aortica aguda, paraparesia por isquemia medular, dolor abdominal por isquemia vísceras abdominales, signos de shock hipovolémico o taponamiento cardiaco

Exploración física:

Ausencia o asimetría pulsos periféricos
Soplo compatible con insuficiencia aórtica
Medir presión arterial en ambos MMSS, al inicio suele haber HTA. La presencia de hipotensión debe hacer sospechar taponamiento cardiaco.

Factores de riesgo/antecedentes de interés:

Aneurisma aórtico conocido
Patología vascular aórtica conocida
Manipulación quirúrgica o percutánea reciente sobre la aorta
Síndrome de Marfan u otras conectivopatias
Antecedentes familiares de disección aórtica

ECG:

Normal en la mayoría de los casos
Puede haber datos de isquemia miocárdica si la disección arterial progresa a las arterias coronarias

Causas:

Síndrome aórtico agudo (disección aortica, hematoma intramural, ulcera penetrante aorta...)

CELDRAN GIL, FRANCISCO 15/12/2020 09:54:02
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-2910d5c2b-3eb3-0a83-da1e-0050569b6280

Emergencias Sanitarias Región de Murcia
C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ªPlanta
30005 Murcia

Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 | Transporte Sanitario UNE 179002

D.Francisco Celdrán Gil

(Documento firmado electrónicamente al margen)

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de Murcia. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en http://10.181.8.6/intranet/

PERFIL ESOFÁGICO / GASTROINTESTINAL

Localización e irradiación:

Retroesternal puede irradiar a parte superior tórax, cuello, brazos y hombros

Intensidad:

Variable, de moderado (esofagitis) a intenso (espasmo)

Duración:

Variable; breve (espasmo), prolongado (esofagitis)

Calidad:

Urente con sensación de quemazón, a veces opresivo

Factores agravantes:

Ingestión de alimentos ácidos o picantes, bebidas muy frías o muy calientes, alcohol, deglución, inclinarse hacia el suelo, maniobras de Valsalva, estrés psicológico en el momento ingestión.

Factores que alivian:

Antiácidos y ortostatismo (esofagitis) o nitratos y los antagonistas del calcio (espasmo)

Síntomas acompañantes:

Pirosis (reflujo), disfagia (trastornos de la motilidad, neoplasia), triada de Mackler (dolor torácico agudo, vómitos y enfisema subcutáneo) indicativo de perforación esofágica

Exploración física:

Normal excepto si hay perforación esofágica (enfisema subcutáneo)

Factores de riesgo/antecedentes de interés:

Antecedentes reflujo gastroesofágico, hernia hiato o disfagia
Sospechar rotura esofágica si empeora con la respiración, ha existido manipulación esofágica reciente (endoscopia, ecografía transesofágica), ingesta de cáusticos o vómitos frecuentes (síndrome Mallory Weiss).

ECG:

Normal o alteraciones inespecíficas de la repolarización

Causas:

Reflujo gastroesofágico o hernia hiato
Disfagia de cualquier causa
Espasmo esofágico
Inflamación o rotura esofágica
Procesos abdominales con dolor torácico referido

CELDRAN GIL, FRANCISCO 15/12/2020 09:54:02
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-2910d5c2b-3eb3-0a83-da1e-0050569b6280

de Murcia
C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ªPlanta
30005 Murcia

Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 | Transporte Sanitario UNE 179002

D.Francisco Celdrán Gil

(Documento firmado electrónicamente al margen)

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de Murcia. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en http://10.181.8.6/intranet/

PERFIL OSTEOMUSCULAR

Localización e irradiación:

Variable, estructura de la pared torácica, músculos intercostales, columna cervical o dorsal.

Intensidad:

Leve o moderado. Nunca intenso.

Duración:

Prolongado, en general semanas o meses.

Calidad:

Punzante, intermitente.

Factores agravantes:

Movimientos torácicos, sobrecarga de peso, tos, estornudos

Factores que alivian:

Reposo, analgésicos y antiinflamatorios, calor seco

Síntomas acompañantes:

Variables, pero nunca se acompaña de datos objetivos de gravedad ni cortejo vegetativo

Exploración física:

Deben buscarse puntos álgidos que se desencadenan con la presión o movilización

Factores de riesgo/antecedentes de interés:

Traumatismo torácico o esfuerzo físico intenso previo

ECG:

Normal

CELDRAN GIL, FRANCISCO 15/12/2020 09:54:02
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-2910d5c2b-3eb3-0a83-da1e-0050569b6280

C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ªPlanta
30005 Murcia

Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 | Transporte Sanitario UNE 179002

(Documento firmado electrónicamente al margen)

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de Murcia. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en http://10.181.8.6/intranet/

PERFIL NEUROLÓGICO

Localización e irradiación:

Sigue el recorrido del nervio o la raíz afectada

Intensidad:

Variable, pudiendo llegar a ser muy intenso

Duración:

Variable, de minutos, horas, e incluso días

Calidad:

Urente, como calor o paso de corriente

Factores agravantes:

Movimientos que aumenten la compresión de la raíz o del nervio

Factores que alivian:

Infiltración de la raíz o nervio afectado

Síntomas acompañantes:

Parestesias, hipostesias y paresias. En las neuritis herpéticas puede haber lesiones cutáneas

Exploración física:

Alteraciones sensitivas o motoras del territorito afectado
Lesiones cutáneas (herpes zoster)

CELDRAN GIL, FRANCISCO 15/12/2020 09:54:02
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-2910d5c2b-3eb3-0a83-da1e-0050569b6280

PERFIL PSICÓGENO O FUNCIONAL

Localización e irradiación:

Inframamario, referido a menudo a hemitórax izquierdo, el ápex cardiaco o la región intercostal lateral. A veces se manifiesta como una sensación de cuerpo extraño que se desplaza con la deglución (globo histérico). Puede irradiarse al miembro superior izquierdo

Intensidad:

Variable, en general poco agudo

Duración:

>30 minutos y puede prolongarse durante días. A veces pocos minutos y recidivante

Calidad:

Punzante, intermitente, aunque puede remedar cualquier perfil

Factores agravantes:

Estrés físico o psíquico

Factores que alivian:

Reposo, relajación y ansiolíticos

Síntomas acompañantes:

Mareo, palpitaciones, parestesias por hiperventilación, disnea, suspiros.

Exploración física:

Normal; a veces taquicardia

Factores de riesgo/antecedentes de interés:

Antecedentes de ansiedad o enfermedad psiquiátrica
Estrés emocional reciente

ECG:

Normal

CELDRAN GIL, FRANCISCO 15/12/2020 09:54:02
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-291d5c2b-3eb3-0a83-da1e-0050569b6280

CARACTERISTICAS DOLOR EN LA TROMBOEMBOLIA PULMONAR

Localización e irradiación:

Región torácica lateral. Puede irradiarse al resto del tórax, cuello y hombros

Intensidad:

Agudo e intenso. En el 20% ausente

Duración:

Variable, en general de horas a días

Calidad:

Puede manifestarse por tres tipos de dolor: pleurítico, isquémico y mecánico

Factores agravantes:

Trombosis venosa profunda, reposo, intervención quirúrgica reciente

Factores que alivian:

A veces el oxígeno, nitratos y la morfina

Síntomas acompañantes:

Disnea, tos, roce pleural, febrícula, hemoptisis, agitación, ansiedad, hipotensión, sincope, shock y muerte súbita

Exploración física:

Anodina. Taquipnea, taquicardia, a veces ritmo de galope, desdoblamiento del 2º tono cardiaco, aumento presión venosa central

ECG:

Lo más frecuente es la taquicardia sinusal.
Puede presentar BCRD o alteraciones inespecíficas de la repolarización.
Patrón S1Q3T3 es infrecuente.

CELDRAN GIL, FRANCISCO 15/12/2020 09:54:02
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-291d5c2b-3eb3-0a83-da1e-0050569b6280

CARACTERISTICAS DOLOR POR CONSUMO DE COCAÍNA

Localización e irradiación:

Retroesternal sin irradiación

Intensidad:

Entre moderado e intenso

Duración:

Desde minutos hasta 2-3 horas

Calidad:

Opresivo o como quemazón

Factores agravantes:

Toma de cocaína

Factores que alivian:

Nitratos, antagonistas del calcio

Síntomas acompañantes:

Euforia, cefalea, palpitaciones

Exploración física:

Taquicardia, taquipnea, midriasis, hipertensión

CELDRAN GIL, FRANCISCO 15/12/2020 09:54:02
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-2910d5c2b-3eb3-0a83-da1e-0050569b6280

CELDRAN GIL, FRANCISCO 15/12/2020 09:54:02

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-291d5c2b-3eb3-0a83-da1e-0050569b6280

DOLOR TORÁCICO

Características	Perfil isquémico	Perfil pericárdico	Perfil pleural	Perfil aórtico	Perfil esofágico	Perfil osteomuscular	Perfil neurológico	Perfil psicógeno o funcional
Localización e irradiación	Retroesternal. Puede irradiar	Retroesternal o precordial.	Región torácica lateral, puede irradiarse al resto tórax y cuello	En parte anterior tórax, espalda, zona interescapular o abdomen.	Retroesternal puede irradiar a parte superior tórax, cuello, brazos y hombros	Variable según estructura afectada	Sigue el recorrido del nervio o la raíz afectada	Inframamario, referido a menudo a hemitórax izqdo.
Intensidad	**Inicio súbito e intensidad variable.**	**Inicio subagudo variable. Rara vez tan intenso como en el IAM**	**Inicio agudo e intenso**	**Inicio muy brusco e intenso**	**Variable, moderado(esofagitis) intenso (espasmo)**	**Leve o moderado. Nunca intenso**	**Variable, pudiendo llegar a ser muy intenso**	**Variable, en general poco agudo**
Duración	Angina típica <10 min angina prolongada >20min IAM >40 min	Variable, en general de días	Variable en general días	Variable de minutos a horas	Variable breve (espasmo) prolongado (esofagitis)	Prolongado, en general semanas o meses	Variable, de minutos, horas, e incluso días	>30 minutos y puede prolongarse durante días. A veces pocos minutos y recidivante
Calidad	**Opresivo, transfixiante, constrictivo con sensación de muerte inminente.**	**Como dolor de carácter pleurítico, coronario o dolor sincrónico con los latidos cardiacos que es patognomónico pero infrecuente**	**Punzante como una cuchillada**	**Desgarrante o lacerante**	**Urente con sensación de quemazón a veces opresivo**	**Punzante, intermitente**	**Urente, como calor o paso de corriente**	**Punzante, intermitente, aunque puede remedar cualquier perfil**
Factores agravantes	Cualquier causa que aumente el consumo de oxigeno miocárdico	Decúbito supino, respiración profunda, deglución, tos, rotación tórax	Movimiento respiratorios profundos, tos, estornudos	Hipertensión, embarazo, síndrome de Marfan	Ingestión alimentos ácidos o picantes, bebidas muy frías o muy calientes,...	Movimientos torácicos, sobrecarga de peso, tos estornudos	Movimientos que aumenten la compresión de la raíz o del nervio	Estrés físico o psíquico
Factores que lo alivian	**Reposo y nitratos**	**Flexión tronco, decúbito prono respiración superficial**	**Respiración superficial, inmovilización zona afectada**	**Control presión arterial y morfina**	**Antiácidos y ortostatismo (esofagitis) o NTG y los antagonistas del calcio (espasmo)**	**Reposo, analgésicos y antiinflamatorios, calor seco**	**Infiltración de la raíz o nervio afectado**	**Reposo, relajación y ansiolíticos**
Síntomas acompañantes	Cortejo vegetativo	Dependen causa: infección vías respiratorias (vírica), síndrome constitucional (neoplasia)	Tos, disnea. Fiebre, hemoptisis (neumonía neoplasia)	Cortejo vegetativo, sincope, déficit neurológico,	Pirosis, disfagia, triada de Mackler	Variables pero nunca se acompaña de datos objetivos de gravedad ni cortejo vegetativo	Parestesias, hipoestesias y paresias.	Mareo, palpitaciones, parestesias por hiperventilación, disnea, suspiros
Exploración física	**Soplo de insuficiencia mitral, ritmo de galope y roce pericárdico**	**Roce pericárdico, signos de taponamiento cardiaco**	**Roce pleural y semiología derrame pleural o de neumotórax**	**Ausencia o asimetría pulsos periféricos**	**Normal excepto si hay perforación esofágica (enfisema subcutáneo)**	**Deben buscarse puntos álgidos que se desencadenan con la presión o movilización**	**Alteraciones sensitivas o motoras del territorito afectado**	**Normal; a veces taquicardia**

Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia
C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ªPlanta
30005 Murcia

AENOR Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001

AENOR Transporte Sanitario UNE 179002

Puesto y firma:
Director Gerente 061.
D.Francisco Celdrán Gil
(Documento firmado electrónicamente al margen)

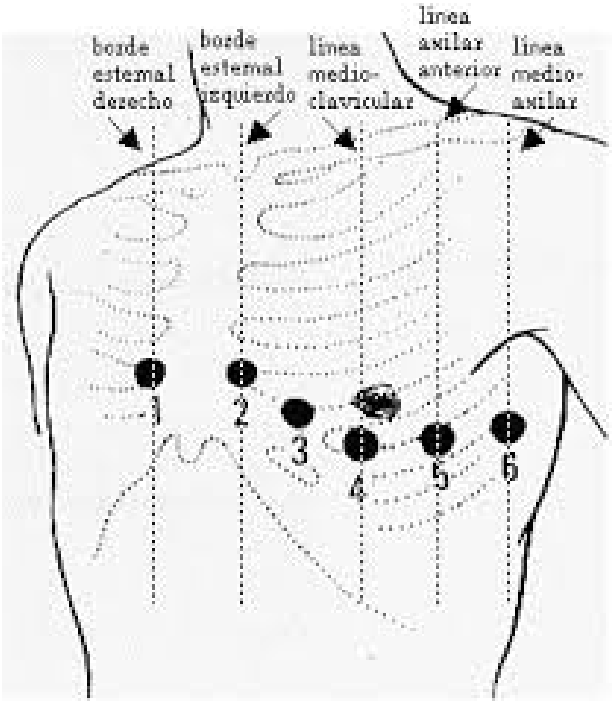
La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de Murcia. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en http://10.181.8.6/intranet/

CELDRAN GIL, FRANCISCO 15/12/2020 09:54:02
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-291d5c2b-3eb3-0a83-da1e-0050569b6280

ANEXO 4. ELECTROCARDIOGRAMA

1. ECG SUPERFICIE 12 DERIVACIONES

1.1. Cable rojo (RA- right arm): muñeca derecha.
1.2. Cable amarillo (LA – left arm): muñeca izquierda.
1.3. Cable verde (LL – left leg): tobillo izquierdo.
1.4. Cable negro (RL – right leg): tobillo derecho.
1.5. V1: 4º espacio intercostal derecho, línea paraesternal derecha.
1.6. V2: 4º espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal izquierdo.
1.7. V3: simétrico entre V2 y V4.
1.8. V4: 5º espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular.
1.9. V5: 5º espacio intercostal izquierdo, línea anterior axilar.
1.10. V6: 5º espacio intercostal izquierdo, línea axilar media.



Fuente de la imagen www.madrid.org

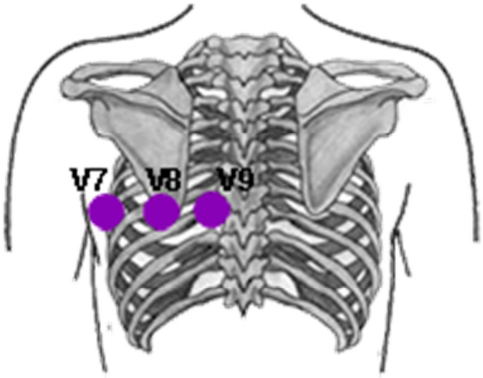
Si el paciente tuviese alguna extremidad amputada, el electrodo correspondiente se colocará en el muñón de dicha extremidad, o en su defecto, en la región del torso más cercana (hombros o región abdominal inferior), colocando el de la extremidad contralateral a la misma altura.

CELDRAN GIL, FRANCISCO 15/12/2020 09:54:02
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-2910d5c2b-3eb3-0a83-da1e-0050569b6280

2. DERIVACIONES POSTERIORES:

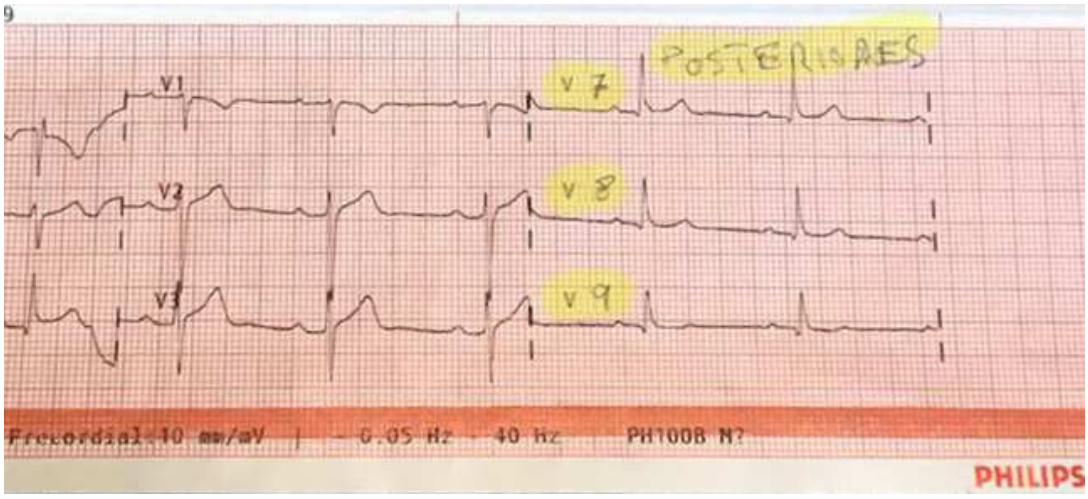
Se realiza colocando los electrodos V4, V5 y V6 en el mismo espacio intercostal que los electrodos precordiales habituales, pero continuando hacia la espalda del paciente:

2.1. V7: 5º espacio intercostal, línea axilar posterior (electrodo V4).
2.2. V8: 5º espacio intercostal, línea medioescapular, a la altura del ángulo inferior de la escápula (electrodo V5).
2.3. V9: 5º espacio intercostal, línea paravertebral izquierda (electrodo V6).



Fuente de la imagen my-ekg.com

Una vez realizado el ECG con derivaciones posteriores, se debe escribir en la cabecera del ECG la palabra POSTERIORES y sobrescribir V7, V8 y V9 sobre las derivaciones que han sido sustituidas por las derivaciones posteriores.

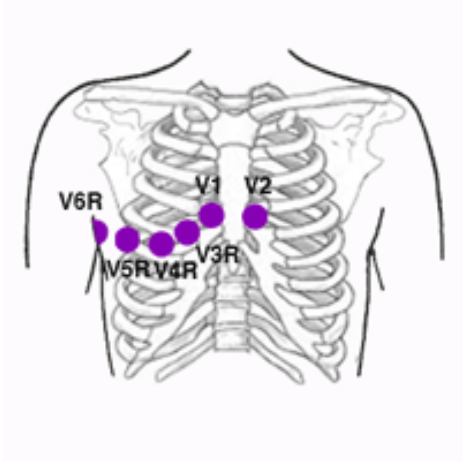


CELDRAN GIL, FRANCISCO 15/12/2020 09:54:02
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-291d5c2b-3eb3-0a83-da1e-0050569b6280

3. DERIVACIONES DERECHAS:

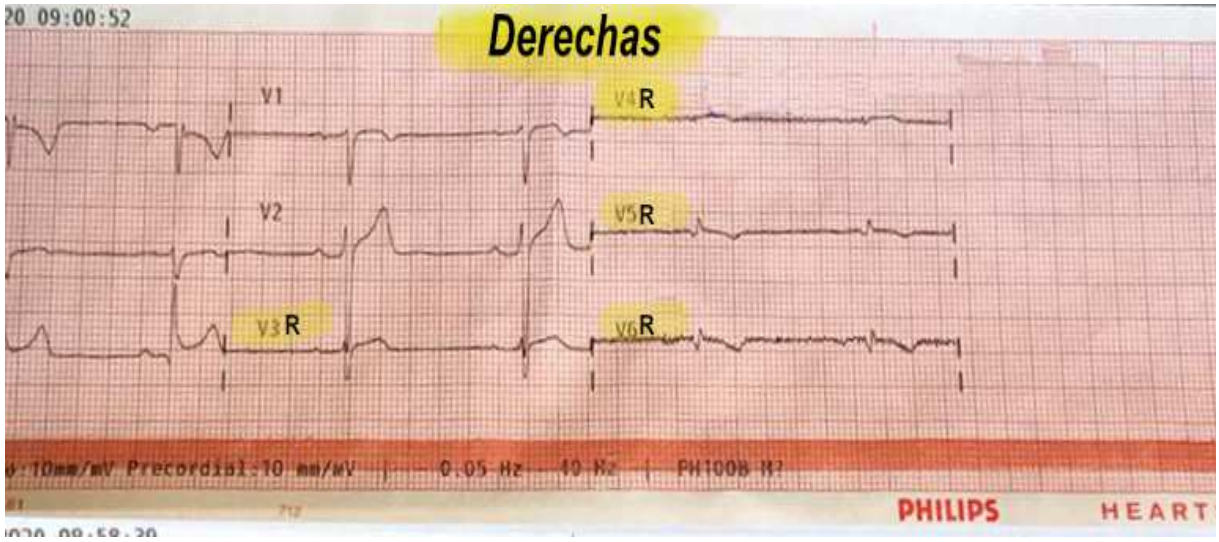
Se realiza colocando los electrodos de forma similar que al realizar un ECG estándar pero colocando los electrodos de V3 a V6 en región precordial derecha:

3.1. V1: mismo lugar (4º espacio intercostal derecho, línea paraesternal derecha)
3.2. V2: mismo lugar (4º espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal izquierda)
3.3. V3R: entre V2 y V4R (electrodo V3)
3.4. V4R: 5º espacio intercostal derecho, línea clavicular media (electrodo V4)
3.5. V5R: 5º espacio intercostal derecho, línea axilar anterior (electrodo V5)
3.6. V6R: 5º espacio intercostal derecho, línea axilar media (electrodo V6)



Fuente de la imagen my-ekg.com

Una vez realizado el ECG con las derivaciones derechas, se debe escribir en la cabecera del ECG la palabra DERECHAS y poner una R al lado del título de la derivación.



CELDRAN GIL, FRANCISCO 15/12/2020 09:54:02
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-291d5c2b-3eb3-0a83-da1e-0050569b6280

11. BIBLIOGRAFIA

1. Torres Murillo JM, Gil Hernández S, Jiménez Murillo L, et al. Dolor torácico agudo. En Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ, editores Medicina de urgencias y emergencias. Guía diagnostica y protocolos de actuación 6ª edición. España: ELSEVIER; 2018. p. 197-203.
2. Cortés Beringola A, Pajín Valbuena LF, Rodríguez Padial L. Dolor torácico. En Julián Jiménez A, coordinador Manual de protocolos y actuación en urgencias 4ª edición. Toledo reimpresión 2016. p 223-234. Disponible en: https://sescam.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/manual_urgencias_re2016.pdf
3. Torres Arrese M, Marchán López A. Dolor torácico [Internet] En Manual de diagnóstico y terapéutica médica. Hospital universitario 12 de octubre 8ª edición. Madrid 2017. Disponible en: https://profesionales.msd.es/medicos/recursos_profesionales/manual-12-octubre.xhtml?docId=1626
4. Jiménez M, Mata A. Dolor torácico [internet].Clínica Universitaria Navarra [última revisión septiembre 2018; Consultado 8 Jul 2019]. Disponible en: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiy9uCR2-LkAhVJOhoKHVEqChEQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cun.es%2Fdam%2Fcun%2Farchivos%2Fpdf%2Fpublicaciones-cun%2Furgencias%2Fguia-actuacion-dolor-toracico&usg=AOvVaw0ER37rC1L1hq5kEYmM-hNU
5. García Criado EI. Dolor torácico agudo [internet] Guía de buena práctica clínica en situaciones de urgencia: Coordinado Toquero de la Torre F, zarco Rodríguez J; 2003. Disponible en: https://www.cgcom.es/sites/default/files/guia_urgencia.pdf
6. Grupo de traballo de urxencias. Dolor torácico en urgencias extrahospitalarias. AGAMFEC.2013. Disponible en: https://www.agamfec.com/antiga2013/pdf/Grupos/Urxencias/Dor_Toracica_Urxencias.pdf
7. Benger J, Constantin I, et al. Consenso para el Manejo de pacientes con dolor precordial. Rev Argent Cardiol 2016;84:378-401. Disponible en:

   https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwja28Oi4-LkAhWJGBQKHb5ZBg4QFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F5647810.pdf&usg=AOvVaw2MFFokIxQL9Y6BebasWcJy
8. Ibañez del Castillo R, Mir Montero M, Bibiano Guillen C. Dolor torácico agudo. En Bibiano Guillen C, editor. Manual de Urgencias 3ª edición. Madrid 2018. P122-126. Disponible en: https://www.urgenciasyemergen.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2018/10/Manual-de-urgencias-3ed-Bibiano.pdf